

Fecha Última Actualización: 25-06-2022 11:40:06

Página 1 de 4

### Información Paciente

**Nombre** : Victor Fuentes Acu?A  
**Edad** : 66a 1m 24d  
**Dirección** : Andacollo 1332

**Rut** : 7.484.851-6  
**Fecha Nacto**: 01/05/1956  
**Comuna** : La Florida

**N° Archivo** : 2208678  
**Sexo** : Masculino  
**Teléfono** :

**N° Epicrisis**  
**309489**

### Información Hospitalización

**Unidad de Ingreso** : Upc - Uci Adulto  
**Unidad de Egreso** : Utim

**Fecha Ingreso** : 04/05/2022 01:32  
**Fecha Egreso** : 25/06/2022 11:06

**Días Estadía**: 52

### Motivo o Diagnóstico de Ingreso

POLITRAUMATISMO + TEC GRAVE

### Comorbilidades

### Procedimientos

### Intervenciones Quirúrgicas

### Epidemiología

### Resumen Clínico

RESUMEN DE TRASLADO  
FI HSR 04.05.22  
FI UCI 04.05.22  
FI Cuidados especiales 01/06/2022

MOTIVO DE CONSULTA: POLITRAUMATISMO + TEC GRAVE

ANTECEDENTES: POLICONSUMO (OH - PASTA BASE)

MOTIVO DE CONSULTA:  
Politraumatismo - TEC

#### HISTORIA DE INGRESO:

Paciente ingresa a HLF el 04/05/22 por caída de altura (se desconoce mecanismo) 2 mts aprox, describen inicialmente GCS 13, que rápidamente deteriora ameritando protección de vía aérea.

Estudio de paciente politraumatizado:

TC de cerebro informa FX occipito- temporo- frontal derecha en conminuta, HSA traumática, contusión de lóbulo temporal derecho, herniación uncal, contusión frontal- temporal izq.

TC de Tórax: hemo neumotórax derecho.

Instalan tubo pleural derecho, y derivan a UPC del HSR.

Ingresa a UPC en soporte VMI, sin soporte sedoanalgesia, midriasis arrefléctica derecha, hipotérmico. Evaluado al ingreso por Neurocirugía, es llevado a pabellón de urgencia el 04/05/22 para evacuación de hematoma temporal + instalación de sensor PIC.

Diagnósticos de ingreso:

1. Politraumatismo

2. TEC Grave

3. Postoperatorio. Evacuación hematoma temporal derecho e instalación captor de PIC

4. Trauma de tórax: Hemo-neumotorax derecho. Fracturas costales en doble foco 1-10 costillas. Pleurostomia derecha

**Fecha Epicrisis** : 25/06/2022 11:40

Página 1 de 4

Fecha Última Actualización: 25-06-2022 11:40:06

Página 2 de 4

- 5. Fractura conminuta escápula derecha
- 6. Fractura clavícula derecha; intraarticular medial y lateral.
- 7. Trauma columna; Fractura cuerpo vertebral T10 y L1, fractura proceso transversal T10
- 8. Obs hematoma suprarrenal izquierdo.
- 9. Antecedentes: Policonsumo

### EVOLUCION:

HDN: Inicialmente con requerimiento de DVA, posteriormente evoluciona normotenso, bien perfundido.

NEURO: Secuelado de TEC grave. Seguimiento de imágenes cerebrales con tendencia a reabsorción de hematoma. Impresiona condición neurológica actual secuelada. Por antecedente de TUS (OH + PBC) se mantiene manejo con suplementación con tiamina. BZD y opioides suspendidos el 05/06. Se mantuvo con compromiso de conciencia que evolucionó favorablemente tras la suspensión de olanzapina. Con buena respuesta a Quetiapina y Benzodicepinas

RESPIRATORIO: Paciente portador de TQT asociado a VMI prolongada por interurrencias infecciosas y delirium/agitación post NCX. Pendiente decanulación.

Ha cursado con 2 hits infecciosos en la esfera respiratoria tratados dirigidamente acorde a microbiología. Sin embargo con importantes atelectasias bibasales de predominio derecho, condicionadas además por Fx múltiples costales derechas, que de momento se había desestimado resolución qx por limitación al posicionamiento en decúbito lateral por FX vertebral D10. Reevaluado por TMT, sin indicación Qx, sin contraindicación para kine respiratoria.

Ha evoluciona en buenas condiciones, con oclusió de TQT con válvula de fonación. Actualmente progresando en ventanas de oclusión, limitado principalmente por aspectos conductuales.

RENAL: Estable durante hospitalización.

INFECTO: Cursa con varios hits infecciosos: obs Neumonía aspirativa, tratada con ampi/sulba. Posteriormente evoluciona con NAAS con aislamiento de Pseudomona sensible a carbapenémicos, por lo que realiza tto con Meropenem /ceftazidima. Traqueobronquitis tratada. Último episodio de traqueobronquitis por PSAE, en tratamiento con amikacina en nebulización.

TRAUMATOLOGÍA: Evaluado por equipo de traumatología, sin indicación quirúrgica de fracturas de columna y costales por ser ya de evolución mayor a 10 días. Sin contraindicación de movilización a posición de decúbito lateral ni kine respiratoria. Se está movilizando a sillón.

REHABILITACION: Evaluado por Fonoaudiología, mal pronóstico de rehabilitación neurológica y deglutoria. Se instala GTT lunes 13/06. Presentó desplazamiento de GTT. Sin filtración. Recibiendo nutrición enteral con Fresubin HP a 60 ml/hora. Pendiente trámite para ley Ricarte Soto de nutrición enteral en domicilio.

### DIAGNÓSTICOS DE EGRESO:

#### 1. Politraumatismo

--TEC Grave:

- Fractura occipitotemporofrontal derecha.
- Qx de Drenaje hematoma temporal derecho e instalación captor d e PIC (04/05/22)
- Trauma de tórax complicado:
- Fracturas costales en doble foco 1-10 costillas Derechas
- Fractura conminuta escápula derecha
- Fractura clavícula derecha; intraarticular medial y lateral.
- Hemoneumotorax derecho (Resuelto)
- TQT 15/05 - cambio cánula 7.5 23/05
- Atelectasias bibasales predominio derecho.
- Trauma columna; Fractura cuerpo vertebral T10 y L1, fractura proceso transversal T10
- Obs Hematoma suprarrenal izquierdo

#### 2. Hits Infecciosos:

- Traqueobronquitis por PsAe, en tratamiento (FI 14/06)
- NAAS por PsAe/SAMS (tratada) 7/7 días Meropenem (Fi 21/05),
- Traqueobronquitis por PsAe/Klebsiella Oxytoca/ ceftazidima 10/05/22-20/05/22

#### 3. Desnutrición calórico proteica severa.

Fecha Epicrisis : 25/06/2022 11:40

Página 2 de 4

Fecha Última Actualización: 25-06-2022 11:40:06

Página 3 de 4

4. Disfagia severa Fils 2
5. Traqueostomía, cánula 7.5
5. Portador de pseudomona resistente a carbapenémicos y Enterococo Van B
6. Antecedentes: TUS (OH + PBC)

### Diagnóstico de Egreso

Traumatismos Múltiples No Especificados - Tec Grave  
Trauma De Tórax: Hemoneumotorax Derecho, Resuelto.  
Fracturas Costales En Doble Foco 1-10  
Fractura Conminuta Escápula Derecha  
Fractura Clavícula Derecha  
Trauma Columna, Fractura Cuerpo Vertebral T10 Y L1, Fractura Proceso Transverso T10.  
Hematoma Suprarrenal Izquierdo

Traqueostomía -  
Disfagia - Disfagia Severa En Rehabilitación.  
Gastrostomía -  
Desnutrición Proteicocalórica, No Especificada -  
Traqueitis Aguda - Traqueobronquitis Por Psae En Tratamiento

**Condición de Egreso** Alta Otro Destino

**Egreso con Catéter Doble J:** NO

Egresada en buenas condiciones generales, HDN estable, afebril.

PCR COVID-19 22/06 negativa.

### Plan Post Alta

Se deriva a POLICENTER para completar rehabilitación.

1. Rehabilitación:
  - Kinesiológica: Kine motora y respiratoria. Progresar rehabilitación para decanulación.
  - Fonoaudiológica: Deglución, manejo de traqueostomía
  - Nutricional: Soporte nutricional enteral por gastrostomía
2. Fresubin HP 60 ml/hra + 20 ml/hra de agua x GTT
3. Amikacina 500 mg cada 12 hrs en NBZ, completar 14 días de tratamiento (Fecha de inicio 14/06/2021)
3. Quetiapina 50 mg cada 12 hrs x SNG
4. Diazepam 10 mg noche x SNG
5. Haloperidol 5 mg EV SOS si agitación, máximo 3 veces al día
6. Omeprazol 40 mg EV día
7. PEG 15 g en 200 cc agua al día x SNG
8. Paracetamol 1 g x SNG cada 8 horas x SNG
9. Br Ipratropio 4 puff cada 4 horas por TQT
10. Enoxaparina 40 mg sc día

### Indicaciones

**Tipo de Reposo** : Levantar A Sillon

**Régimen Alimentario** : Nutrición Enteral

**Medicamentos** :

### Controles

Fecha Epicrisis : 25/06/2022 11:40

Página 3 de 4

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 15:10

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

# Epicrisis Hospitalaria

**ESTADO: DEFINITIVA**



COMPLEJO ASISTENCIAL

**DR. SÓTERO DEL RÍO**  
JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 25-06-2022 11:40:06

Página 4 de 4

INTERNO

Bec. Marcelo Contreras Chávez

Becado/Residente

Jorge Verdugo Muñoz

Médico Tratante (Staff)